

Interwencja *formalna*

Zorganizowane spotkanie bliskich z osobą uzależnioną — kiedy ma sens, w jakim modelu, kto powinien je prowadzić i kiedy nie robić jej w ogóle.

CZAS: 20 min na zapoznanie Realizacja wymaga przeszkolonego terapeuty

ŹRÓDŁO: Johnson (1973); Garrett i wsp. (1997, ARISE); Landau i wsp. (2004)

JAK UŻYWAĆ

Arkusze wyjaśnia **dwa modele interwencji formalnej**: *Johnson* (konfrontacja, lata 70.) i *ARISE* (stopniowany, lata 90.). Sekcja 01 — porównanie. Sekcja 02 — **trzy etapy ARISE**. Sekcja 03 — kiedy *nie* robić interwencji. Sekcja 04 — wstępna lista, kto miałby uczestniczyć.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klasyczna *interwencja Johnsona* (1973) — zorganizowana z *zaskoczenia* konfrontacja rodziny z osobą uzależnioną — ma **niską skuteczność** (~13%, Meyers 2002). *ARISE* (ang. *A Relational Intervention Sequence for Engagement*, Garrett 1997) zastąpiła ją modelem *stopniowanym*, w którym osoba uzależniona wie, że spotkanie się odbywa. Landau i wsp. (2004): **83%** wejścia w leczenie. Praktyczna kolejność: *CRAFT* jako pierwsza linia → *ARISE* gdy *CRAFT* nie dał efektu po 12-14 sesjach → *Johnson* ostatecznością. Interwencja samodzielna, bez przeszkolonego terapeuty, potrafi **pogorszyć** sytuację.

01 ? Dwa modele — Johnson vs ARISE

MODEL JOHNSONA — KONFRONTACJA Z ZASKOCZENIEM

Bliscy przygotowują się w *tajemnicy*. Spotkanie odbywa się **bez uprzedzenia** osoby uzależnionej. Każdy mówi, jak picie zraniło. Stawiane jest ultimatum.

Skuteczność wejścia w leczenie: ~13%

Koszt emocjonalny: wysoki, ryzyko traumatyzacji

ARISE — SEKWENCJA STOPNIOWANA

Osoba uzależniona *wie*, że spotkanie się odbywa i o czym będzie. Proces jest **stopniowany** — 3 etapy, każdy z opcją zatrzymania, jeśli wystarczy.

Skuteczność wejścia w leczenie: ~83%

Koszt emocjonalny: umiarkowany, niższe ryzyko eskalacji

Praktyczna zasada kolejności: **CRAFT** (12-20 sesji indywidualnie z bliskim) → jeśli po 14 sesjach nie ma efektu → **ARISE** z całą rodziną → **Johnson** tylko w specjalnych okolicznościach (np. zagrożenie życia + brak innych dróg).

02 📋 ARISE — trzy etapy

ETAP 1 · ZAPROSZENIE

55% angażuje się tutaj

Bliscy **otwarcie zapraszają** osobę uzależnioną na rozmowę o jej picie. Nie zasadzka. „Kochamy Cię, martwimy się, chcielibyśmy porozmawiać razem.” Wielu pacjentów na tym etapie godzi się na leczenie bez dalszych kroków.

ETAP 2 · SPOTKANIE RODZINNE

25% angażuje się tutaj

Osoba uzależniona + bliscy + **terapeuta**. Każdy mówi z pozycji JA: jak picie wpłynęło na *moje* życie. Proponowane są **konkretne opcje leczenia** (nazwy poradni, terminy). Bez ultimatum.

ETAP 3 · KONSEKWENCJE

3% angażuje się tutaj

Bliscy formułują **realne i wykonalne** konsekwencje, jeśli leczenie nie zostanie podjęte. *Bez pustych gróźb*. To granica, którą wszyscy są gotowi utrzymać.

Większość rodzin nie dochodzi do etapu 3 — wystarczają 1-2. **Suma** wszystkich etapów: ~83% wejścia w leczenie.

03 ✕ Kiedy nie robić interwencji formalnej

BEZ PRZESZKOLONEGO TERAPEUTY

Interwencja samodzielna potrafi **pogorszyć** sytuację — eskalacja, traumatyzacja bliskich, definitywne odcięcie się osoby uzależnionej. Przeszkolony terapeuta utrzymuje proces w bezpiecznych ramach.

RYZYSKO PRZEMOCY

Jeśli osoba uzależniona była w przeszłości agresywna, interwencja może wywołać eskalację. **Najpierw plan bezpieczeństwa**, dopiero potem rozważanie interwencji — i tylko z indywidualną oceną ryzyka.

AKTYWNA PSYCHOZA LUB CIĘŻKA DEPRESJA

Jeśli osoba uzależniona ma aktywną psychozę, ciężką depresję z myślami samobójczymi lub jest w trakcie odstawienia — **najpierw stabilizacja medyczna**, interwencja później.

BLISCY NIE GOTOWI NA KONSEKWENCJE

Interwencja z *pustymi groźbami* jest **gorsza niż brak interwencji**. Uczy osobę uzależnioną, że słowa rodziny nie mają wagi. Najpierw przygotowanie indywidualne (CRAFT), potem ewentualnie ARISE.

04 ✎ Mój zespół — wstępna lista przed konsultacją z terapeutą

Jeśli rozważasz ARISE, terapeuta zwykle prosi o listę osób, które miałyby uczestniczyć. Zwykle 3–6 osób — bliskie, godne zaufania, gotowe wytrzymać proces. *Bez osób z aktywnym własnym uzależnieniem ani z silnym konfliktem z osobą uzależnioną.*

OSOBA 1

— relacja, dlaczego ważna

OSOBA 2

OSOBA 3

OSOBA 4

— opcjonalnie

TERAPEUTA LUB PORADNIA, Z KTÓRĄ BĘDĘ KONSULTOWAĆ PLAN

— imię, kontakt

Klucz: Interwencja formalna to *nie pierwsza linia* — to narzędzie w *specyficznym momencie*, gdy łagodniejsze drogi (CRAFT, rozmowa indywidualna, Al-Anon) nie przyniosły efektu. Garrett (1997): „Najczęstszym błędem rodzin nie jest brak interwencji — jest organizowanie jej *za szybko*, bez przygotowania, bez wsparcia profesjonalnego.” Spokojne, długotrwałe CRAFT z jednym członkiem rodziny często okazuje się skuteczniejsze niż dramatyczne spotkanie całej rodziny w jeden wieczór.